

IMC = 41.

NS Bmc

YOLANDA SOUSA ROBERTO			
IDADE: 53	PESO: 92	ALTURA: 145	PROFISSÃO: Aux. Ser. Gerais.
SINTOMAS: <i>ansiedade; sonolência / acorda muitas vezes à noite</i>			
QUEIXAS: <i>euforico, sono agitado.</i>			
MEDICAMENTOS: <i>Levoir / Serastatina / glifage.</i>			
MÉDICO: <i>Dr. Leandro Balli</i>			
EXERCÍCIO FÍSICO: <i>não</i>			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: <i>S</i> ALMOÇO: <i>S</i> LANCHE: <i>S</i> JANTAR: <i>19:30</i>			
HORA QUE DORME: <i>21:30</i>		HORA QUE ACORDA: <i>4:45</i>	
COCHILHO () SIM ☒ NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM ☒ NA SEMANA () NÃO <i>às vezes vinho</i>			
FUMO () SIM () NÃO / DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: <i>nasal</i> BANHEIRO: <i>3X</i>			
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: <i>globo</i>		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: <i>não</i>	MALLAMPATI: <i>IV</i>	IAH: <i>33.8</i>	SPO2: <i>80%</i>
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: <i>Tireoide / Colesterol</i>			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA () CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS			
<i>for em m m I - a noite - mov. de m m I.</i>			
<i>27/11/23 Adaptação CPAP automática</i>			
<i>13/12/23 P = 6.7 max. / Mediana 4.9 cmH₂O</i>			
<i>IAH = 0.8</i>			
<i>m. de uso = 6h41'</i>			
<i>ajuste o CPAP. fua.</i>			
<i>21/12/23 P = 5.2 cmH₂O</i>			
<i>IAH = 0.6 e/ev</i>			
<i>m. de uso: 6:30'</i>			
<i>19/02/24 P = 5.5 cmH₂O</i>			
<i>IAH = 1.2 e/ev</i>			
<i>m. de uso: 17.7 e/ev</i>			
<i>acabou a sonolência fua. claudia</i>			
<i>20/03/24 P = 7.0 cmH₂O</i>			
<i>IAH = 1.5 e/ev</i>			
<i>m. de uso: 5h44'</i>			
<i>Bem adaptada - fua</i>			
<i>21/05/24 P = 7.0 cmH₂O</i>			
<i>IAH = 0.5 e/ev</i>			
<i>m. de uso: 6m</i>			
<i>fua</i>			
<i>24/07/24 P = 7.0</i>			
<i>IAH =</i>			
<i>m. de uso =</i>			
<i>fua</i>			

12/09 P= 5,7cmH₂O
24 IAH = 0,5 e/h
m. de uso: 5h 07'

13/11/24 P= 5,4cmH₂O
IAH = 0,6 e/h
m de uso: 5h 48'

Natasha

17/02 P= 5,4cmH₂O
25 IAH = 0,8 e/h
M. de uso: 7hr
fuga=

Sonolência diurna, porém esta
colocando o CPAP muito tarde.
fuga crônica

MEDICAMF

SINTOM

BANH

HOR

HOR

SON

CAI

19

2

Nome: YOLANDA SOUSA ROBERTO

Data de Nascimento: 17-1-1970

IMC: 41,65

Sexo: Feminino

Data do exame: 29-07-2022

Peso: 90 kg

Altura: 1,47 m

Médico: DR. LEANDRO V. S. BALBI

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 29-07-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 528,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 35,5 e 108,0 minutos. O tempo total de sono foi de 416,0, eficiência de 78,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,0%; estágio N2: 59,9%; estágio N3: 17,9%; sono REM: 19,2%. O índice de despertares foi de 15,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 33,8/hora, sendo elas 43 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 167 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 80%, permanecendo 9,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 62 - 106 bpm e NREM de 66 - 101 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (21), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 33,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=80%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (4,0/hora);
8. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mário Simões da Costa

Medicina do Sono

CRM 57157